

Pojedynczy uraz *kontra* powtarzająca się trauma

PTSD i C-PTSD to nie ilościowe warianty. Inne predyktory, inne objawy, inne leczenie. Cloitre i in. (2019) potwierdzili empirycznie.

CZAS: 10 min psychoedukacji **REALIZACJA:** faza diagnostyczna

ŹRÓDŁO: Cloitre i in. (2013, 2014 LCA; 2019 metaanaliza); Brewin i in. (2017, *review*); Herman (1992); ICD-11 (2018)

JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — **kluczowe różnice strukturalne** między PTSD a C-PTSD (rodzaj traumy, czas trwania, kontekst, struktura objawów). W sekcji 02 — **implikacje lecznicze**: dlaczego ten sam protokół (np. CPT, PE) działa różnie u jednego i drugiego pacjenta. Sekcja 03 — **wstępne pytania kontrolne**: czy moje doświadczenie układa się bliżej PTSD czy C-PTSD. Sekcja 04 — twoja mapa diagnostyczna do rozmowy z klinicystą.

DLACZEGO TO DZIAŁA

PTSD i C-PTSD *nie* są ilościowymi wariantami tego samego zaburzenia — są **strukturalnie odrębnymi** jednostkami klinicznymi. Cloitre i in. (2013, 2014) przeprowadzili analizę klas ukrytych (ang. *latent class analysis*) na próbach klinicznych — empirycznie wyodrębnili dwie odrębne klasy pacjentów, nie kontinuum. Brewin i in. (2017, *review*): C-PTSD ma odrębny profil objawowy, czynniki ryzyka i odpowiedź na leczenie. **PTSD** (kod ICD-11 6B40, DSM-5): reakcja na *pojedyncze* lub *ograniczone* czasowo zdarzenie traumatyczne (wypadek komunikacyjny, napaść, katastrofa naturalna, akt terroryzmu). Strach jest *kontekstowy* — związany ze specyficznym bodźcem. Standardowe leczenie: terapia *prolonged exposure* Foa, terapia poznawczego przetwarzania Resick (CPT), EMDR Shapiro — bezpośrednie przetwarzanie traumy jest skuteczne i bezpieczne. **C-PTSD** (kod ICD-11 6B41): reakcja na *powtarzającą się, przewlekłą traumę interpersonalną*, zazwyczaj w warunkach uwięzienia (dosłownego lub relacyjnego — dzieciństwo, długotrwała przemoc domowa, handel ludźmi, tortury, sytuacje niewoli). Strach jest *uogólniony* — przeniesiony na całe relacje, ciało, świat. Dochodzą trzy domeny DSO (dysregulacja afektu, negatywna koncepcja siebie, zaburzenia relacyjne). Standardowe leczenie: **najpierw stabilizacja** (Herman, 1992; Cloitre i in., 2010; ISTSS, 2019). Cloitre i in. (2012, RCT): fazowe STAIR + NST przewyższało samą ekspozycję u osób po powtarzającej się traumie dziecięcej. Bezpośrednia ekspozycja w C-PTSD *bez* wystarczającej stabilizacji prowadzi do **retraumatyzacji** — nasilenia dysocjacji, dekompensacji, porzucenia terapii. Praktyczna implikacja: *klient po napaści (1x zdarzenie) i klient po 18 latach przemocy domowej nie mogą dostać tego samego protokołu*. Pierwszy odzyskuje funkcjonowanie po 8-12 sesjach CPT; drugi destabilizuje się w 3. sesji.

01



Kluczowe różnice strukturalne

WYMIAR	PTSD	C-PTSD
Rodzaj traumy	Pojedyncze lub ograniczone czasowo zdarzenie (wypadek, napaść, katastrofa)	Powtarzająca się, przewlekła trauma interpersonalna w okresie zależności
Kontekst	Możliwość ucieczki istniała; trauma była „zewnątrzna”	Niemożliwość ucieczki (dziecko, partner przemoc, niewola, tortury, handel ludźmi)
Charakter lęku	Kontekstowy — związany ze specyficznym bodźcem	Uogólniony — przeniesiony na relacje, ciało, świat
Struktura objawów	3 klaster PTSD: intruzje, unikanie, zagrożenie. Tożsamość zwykle nienaruszona.	3 klaster PTSD + 3 DSO. Tożsamość ukształtowana przez traumę.

02 ? Implikacje lecznicze — kluczowa różnica

PTSD — KRÓTKOTERMINOWO

8-12 sesji: terapia *prolonged exposure* (Foa), terapia poznawczego przetwarzania (Resick, CPT), EMDR (Shapiro). Bezpośrednie przetwarzanie traumy jest skuteczne i bezpieczne. Cel: integracja wspomnienia w autobiografię.

C-PTSD — FAZOWO, DŁUGOTERMINOWO

2-5 lat lub dłużej: faza 1 stabilizacja (6-24 mies.), faza 2 przetwarzanie (EMDR z modyfikacjami, STAIR + NST, Schema Therapy, IFS), faza 3 integracja. Bezpośrednia ekspozycja bez Fazy 1 = retraumatyzacja.

03 ☉ Pytania kontrolne — bliżej PTSD czy C-PTSD?

To *nie* diagnoza. To wstępna mapa do rozmowy z klinicystą (psycholog/psychiatra znający ITQ i ICD-11).

SYGNAŁY BLIŻEJ PTSD

- ☐ Trauma: pojedyncze, identyfikowalne zdarzenie
- ☐ Możliwa była ucieczka (lub nastąpiła)
- ☐ Lęk skupia się na specyficznych bodźcach
- ☐ Tożsamość sprzed traumy jest zachowana
- ☐ Relacje (poza tematem traumy) funkcjonują
- ☐ Wstyd jest sytuacyjny, nie głęboki

SYGNAŁY BLIŻEJ C-PTSD

- ☐ Trauma: powtarzająca się, przewlekła, w okresie zależności
- ☐ Niemożność ucieczki (dziecko, partner, niewola)
- ☐ Lęk uogólniony — relacje, ciało, świat
- ☐ Tożsamość ukształtowana przez traumę
- ☐ Trudności relacyjne stałe, nie tylko z traumą
- ☐ Głęboki, zinternalizowany wstyd — „jestem zły/-a”

04 ✎ Moja mapa diagnostyczna

RODZAJ MOJEJ TRAUMY

— pojedyncze zdarzenie / powtarzająca się / przewlekła; w jakim okresie życia, jak długo trwała

CZY OBECNE SĄ TRZY DSO

— dysregulacja afektu / negatywne self / trudności relacyjne; krótko, które z nich rozpoznaję

WSTĘPNA HIPOTEZA

— bliżej PTSD / bliżej C-PTSD / nie wiem; co skłania mnie do tej hipotezy

PYTANIE DO KLINICYSTY

— co chcę zapytać podczas konsultacji; np. „czy moja terapia powinna być fazowa?”

Klucz: klient po napaści (jednorazowe zdarzenie) i klient po 18 latach przemocy domowej *nie* powinni dostać tego samego protokołu terapeutycznego. Pierwszemu pomoże 8-12 sesji terapii ekspozycyjnej; drugi w 3. sesji ekspozycji bez Fazy 1 dysocjuje, dekompensuje, porzuca terapię z poczuciem „terapia mnie pogorszyła”. To *nie* wina pacjenta — to wina niewłaściwego protokołu dla niewłaściwej diagnozy. Cloitre i in. (2012, RCT): fazowy STAIR + NST przewyższał samą ekspozycję u osób po powtarzającej się traumie dziecięcej. Rozróżnienie PTSD-C-PTSD nie jest etykietowaniem — jest *kluczowym* wyborem klinicznym o trafności protokołu.

△ Diagnoza wymaga oceny przez klinicystę znającego ICD-11 i ITQ (International Trauma Questionnaire, Cloitre i in., 2018). DSM-5 nie ma osobnej kategorii C-PTSD — klinicyści szkoleni wyłącznie w DSM-5 mogą jej nie diagnozować, mimo że objawy spełniają kryteria ICD-11. Jeśli twój obecny klinicysta odrzuca kategorię C-PTSD jako „niepotrzebną” — rozważ konsultację z innym specjalistą znającym wytyczne ISTSS 2019.